

Gicht – hochakute Monarthritis und das septische Gelenk

Kristallarthropathie im Direktzugang · Pass T (d): Typografie + wiederkehrende Icons

⚠ Gefahr im Direktzugang: Eine „typische Podagra“ kann eine septische Arthritis maskieren; Kristallnachweis und Gichtanamnese entwarnen **nicht**.

Big Picture

Die Gicht ist die klinische Manifestation einer Hyperurikämie mit Ablagerung von Natriumuratkristallen in Gelenken und Weichteilen. Im Direktzugang dominiert der *hochakute, hochschmerzhafte Monoarthritis-Anfall* – klassisch am Großzehengrundgelenk (Podagra), mit Rötung, Überwärmung und oft Belastungsunfähigkeit, typischerweise innerhalb von Stunden.

Die größte Gefahr ist die **Fehllabelung**: Ein heißes Gelenk mit Fieber oder Systemik darf nicht als „nur Gicht“ abgetan werden. Die HP Physio screent auf Infekt- und Systemzeichen, triagiert und belässt Diagnosesicherung sowie medikamentöse Anfallstherapie in ärztlicher Hand; bei Systembedrohung **112**, bei heißem Gelenk mit Infektverdacht gleichtags die **Notaufnahme**.

ZEIT	Akut innerhalb von Stunden – nicht Tage.
ORT	Klassisch MTP-I (Podagra); auch andere Mono-Gelenke.
NICHT ENTWARNEN	Kristalle und Gichtanamnese schließen septisch nicht aus.

1. Wann ist daran zu denken?

WER / RISIKEN	Hyperurikämie; purinreiche Ernährung; Alkohol; Diuretika; Adipositas; eingeschränkte Nierenfunktion.
KONTEXT	Frühere Attacken oder Tophi; metabolisches Syndrom; Nierenerkrankung; Hautläsionen/Ulzera über Tophi (Infektkomplikation).
WANN / TRIGGER	Akut innerhalb von Stunden; oft nach Alkohol, festlicher Mahlzeit oder Medikamentenänderung. Rezidive stützen den Verdacht, entwarnen nicht bei Systemik.

2. Entstehung (kurz)

Erhöhte Harnsäurespiegel → Natriumuratkristalle in Synovia und periartikulär → rasche neutrophile Entzündung mit Schmerz, Rötung, Schwellung. Chronisch: Tophi und Gelenkschaden.

Direktzugang: Das Bild der Kristallarthropathie ist eindrucksvoll, klinisch oft **nicht** sicher von bakterieller Arthritis zu trennen; Superinfektion von Tophi/Gelenk bleibt möglich.

3. Klinische Hinweise

Domäne	Erwartbare Merkmale
Anamnese	Hochakuter Mono-Gelenkschmerz binnen Stunden; oft MTP-I; frühere Attacken; Alkohol, Diuretika, purinreiche Kost; Fieber? Hautverletzung?
Beobachtung	Rötung, Überwärmung, Schwellung; Schonhaltung; ggf. Tophi; bei Systemik mitgenommener Gesamteindruck
Untersuchung	Starke Druck- und Bewegungsschmerzhaftigkeit; oft Belastungsunfähigkeit; grobe Funktionsprüfung ohne forcierte Manipulation am unklar heißen Gelenk
Verlauf	Anfall: Stunden bis wenige Tage; rezidivierend möglich; polyartikulärer Entzündungsturm mit Systemik ≠ gewöhnlicher Gichtschub

4. Verdacht, Abgrenzung, Warnsignale

✓ ERHÄRTET	Hochakute Monarthritis binnen Stunden, typisch MTP-I; starke Rötung/Überwärmung; Hyperurikämie oder frühere Attacken; passender Trigger – ohne schwere Systembedrohung.
✗ PASST EHER NICHT	Rein mechanisches Trauma mit klarer Verletzungsmechanik ohne entzündliches Bild; chronisch-symmetrische Polyarthritis kleiner Gelenke ohne akuten Mono-Schub.
🕒 NICHT ÜBERSEHEN	Septische Arthritis; Pseudogicht/CPPD (oft Knie); Trauma/Fraktur; Erysipel angrenzend; RA/SpA-Schub; Tophi-Infekt.

Trägerische Erklärungen

1. **„Umgeknickt / Podagra als Distorsion“** – Fehlt adäquate Traumamechanik und zeigt sich ein entzündliches Bild: Gicht und Infekt mitdenken.
2. **„Bekannte Gicht – also nur Schub“** – Gichtanamnese und Kristallnachweis schließen bakterielle Gelenkinfektion **nicht** aus; Fieber/Systemik → Infekt-Triage.
3. **„Knie-Schub = immer Gicht“** – Am Knie oft CPPD; septische Arthritis bleibt Must-not-miss.

DDx-Minimal

Eher ...	Diskriminierende Unterschiede
Gicht	Hochakut Stunden, oft MTP-I, Trigger Alkohol/Diuretika – ohne schwere Systembedrohung

Eher ...	Diskriminierende Unterschiede
Septische Arthritis	Heißes Gelenk + Fieber/Systemik/Belastungsunfähigkeit; auch bei Gichtanamnese bis Ausschluss
CPPD	Oft größere Gelenke (Knie); im Erstkontakt oft untrennbar
Trauma / Fraktur	Klare Mechanik; entzündliches Mono-Bild fehlt oder atypisch
Erysipel	Primär kutan; Gelenk oft freier — im Zweifel nicht herabstufen

5. Handeln und Dringlichkeit

Stufen als **Typoränge** (kein Farbslab) — Scan über Gewicht und Reihenfolge.

01 112

Heißes, geschwollenes Gelenk **plus** Fieber/Systemik **plus** AZ-Verschlechterung / Sepsis-Zeichen; polyartikulärer Entzündungsturm mit schwerer Systembedrohung. → Abbrechen; Vitalzeichen; **112**; keine Manipulation, keine Injektion.

02 Notaufnahme / gleichtags

Akutes heißes Mono mit Belastungsunfähigkeit oder stärkstem Ruheschmerz (**auch ohne** Fieber); heißes Gelenk mit Fieber/Systemik; nach i.a. Injektion/OP/Trauma; Hochrisiko. → PT abbrechen; **noch heute** NA. Bis Ausschluss septisch ausgehen.

03 Zeitnah Fach-/Hausarzt

Nur **bereits ärztlich eingeordnetes** rezidivierendes Muster **ohne** aktuelles heißes Mono mit Belastungsunfähigkeit und **ohne** Systemik. → Keine endgültige Gichtdiagnose im HP-Setting; Sicherheitsnetz.

04 Behandeln mit Sicherheitsnetz

Stabiles, bereits ärztlich eingeordnetes Muster ohne Red Flags; interprofessionell abgestimmt nach Anfall. → Schmerzarmer Bewegungsrahmen; keine forcierte Belastung im akuten heißen Anfall.

Grenze / absolute Kontraindikationen bis Ausschluss



Keine Punktion, keine Intraartikulär-Injektion durch HP, keine forcierte Manipulation am unklar heißen Gelenk; kein abwartendes „Probebehandeln“ bei Fieber/Systemik.

6. Fall zur Selbstprüfung

Situation

54-jähriger Mann, seit gestern Nacht „wieder Podagra“ am rechten Großzeh. MTP-I gerötet, heiß, extrem berührungsempfindlich; belastet den Vorfuß nicht. Regelmäßig Bier, Thiazid-Diuretikum. Heute Fiebergefühl, oral 38,3°C, abgeschlagen. Bittet um „lokale Entlastung und Mobilisation wie beim letzten Schub“.

VORDERGRUND

Heißes Mono + Fieber/Systemik → Infekt-Triage, **nicht** „nur Schub“.

KONTRAINDIZIERT

Mobilisation, forcierte Manipulation, Injektion, abwartendes Probebehandeln.

NÄCHSTER SCHRITT

Sitzung beenden → NA/112 je AZ; septisch bis Ausschluss.

Parent-System V-3 · heißes Gelenk: bakterielle Arthritis mitdenken · Kristalle entwarnen nicht · wave-d / T